Samedi 02: Dg & PEC Tuberculose Latente

Cas clinique : Infection Tuberculeuse Latente (ITL) chez un contact tuberculeux

1. Énoncé clinique

- **Patient :** Ali, 8 ans, vivant à Constantine.
- **Contexte épidémiologique :** Contact étroit avec son grand-père, récemment diagnostiqué avec une tuberculose pulmonaire à frottis positif (bacillifère).
- **Statut vaccinal :** Vacciné par le BCG à la naissance.
- **Examen clinique :** Patient asymptomatique, bien portant (aucun signe clinique de tuberculose active).
- **Examens complémentaires :**
    - **Intradermoréaction (IDR) à la tuberculine :** Induration de 12 mm > 10 mm.
    - **Radiographie pulmonaire :** Normale.

---

2. Question

Quelle est la conduite à tenir ?

- **A.** Rassurer la famille, aucune mesure n'est nécessaire
- **B.** Prescrire un traitement antituberculeux complet pendant 6 mois
- **C.** Déclarer le cas comme TB active
- **D.** Prescrire un traitement préventif de l'ITL
- **E.** Répéter l'IDR dans 3 mois

---

3. Réponse et Justification

- **Réponse correcte : D. Prescrire un traitement préventif de l'ITL**

- **Justification / Commentaires :**

    - Enfant < 15 ans, contact étroit d'un cas de tuberculose pulmonaire bacillifère → indication forte de traitement préventif si la tuberculose active est exclue.
    - IDR > 10 mm.
    - Absence de signes cliniques et radiologiques de tuberculose active.
    - **Schémas thérapeutiques préventifs recommandés :**
        - Isoniazide (INH) pendant 6 mois, **ou**

- Isoniazide + Rifampicine (INH + RIF) pendant 3 mois (selon le guide national).